

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

J.T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Es una neuropatía por atrapamiento o presión del nervio mediano a nivel del túnel carpiiano, el túnel carpiiano esta formado por huesos del carpo y el ligamento carpiiano transverso en la cara palmar de la muñeca. Al comprimir el nervio mediano podemos encontrar síntomas como hormigueos, acorchamientos, calambres, entumecimiento y debilidad de la mano, especialmente en los dedos pulgar, índice, medio y parte del anular.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa fundamentalmente en el examen físico orientado a confirmar o descartar el síndrome del túnel carpiiano y se confirma con pruebas complementarias y de imagen.

1. Examen físico

Los síntomas de sospecha podemos encontrar adormecimiento, parestesias y dolor a nivel de muñeca y mano sobre el territorio del nervio mediano. En la exploración física puede existir síntomas iniciales más precoces que los sensitivos como una discreta atrofia de eminencia tenar y una leve debilidad de la musculatura (abductor corto, flexor corto y oponente del primer dedo).

Los signos fundamentales que orientan al diagnóstico son:

- **Signo de Tinnel:** percutimos con el martillo de reflejos sobre el ligamento anular -cara ventral muñeca- produce sensación de adormecimiento/descarga eléctrica sobre el segundo y tercer dedo.
- **Signo de Phalen:** Consiste en la flexión máxima de ambos carpos durante 2 minutos producirá parestesias.
- **Signo de sacudida (Flick):** es positivo cuando el paciente sacude la mano como lo hace para bajar la temperatura de un termómetro. Al ser preguntado "¿Qué hace usted con la mano cuando los síntomas son intensos?" responde agitar la mano de la misma manera que lo hace para bajar la temperatura de un termómetro.

2. Exámenes de laboratorio

- **Analítica sanguínea.** Hemograma, coagulación básica, bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, PCR/VSG, GOT. GPT. uricemia, ANA, FR, TSH y T4

3. Pruebas de imagen

- **Radiografía muñeca.** Rx de Mano y muñeca AP y axial. Se deberá de solicitar ambas manos y muñecas.
- **Radiografía cervical.** Si sospecha de radiculopatía cervical
- **Electrofisiológicas.** Se coloca electrodos en la mano y la muñeca. Se aplican pequeñas descargas eléctricas y se mide la velocidad con la que se transmiten los impulsos nerviosos.
- **Electromiograma.** Consiste en la introducción de una aguja en el músculo inervado por el nervio que se está estudiando para medir su actividad eléctrica. Mide la velocidad de conducción nerviosa sensitiva y motora del nervio mediano en la muñeca. El componente sensorial del nervio se ve afectado mucho antes que el motor. En las neuropatías por atrapamiento hay un retraso en la velocidad de conducción motora y sensitiva en el punto de compresión por la desmielinización del nervio mediano.

- **Ecografía.** Contribuye al diagnóstico del síndrome del túnel carpiano, permite determinar y descartar en algunos casos otras causas que lo genera desde un ganglión, tenosinovitis, artritis de carpo, etc.
- **TAC de muñeca.** Son útiles para el diagnóstico diferencial que para el etiológico.
- **Resonancia magnética nuclear de muñeca.** Son útiles para el diagnóstico diferencial que para el etiológico.

4. Diagnóstico diferencial

- Diabetes.
- Hipotiroidismo.
- Fibromialgia.
- Vasculitis.
- Anemia perniosa.

5. Etiología

- Idiopática 50%.
- Traumatismos de repetición.
- Tenosinovitis de flexores.
- Artritis inflamatorias (artritis reumatoide)

TRATAMIENTO

El tratamiento dependerá de la clínica que presente el paciente.

1. Caso leve-moderado: El tratamiento médico consistirá en tratamiento conservador con

- Evitar actividades repetitivas desencadenantes.
- Usar férulas nocturnas.
- AINEs vía oral o intramuscular.
- Corticoides orales.
- Infiltraciones con corticoesteroides.

2. Caso graves: El tratamiento es quirúrgico.

Indicaciones de tratamiento quirúrgico

- Persistencia síntomas a pesar tratamiento médico
- Electromiograma muy patológico
- Déficit sensitivo o motor establecidos (atrofia eminencia tenar)
- Lesión ocupante espacio
- Síntomas severos o progresivos de más de 12 meses

Contraindicaciones tratamiento quirúrgico

- Tumoraciones.
- Neurinomas.
- Quistes sinoviales o gangliones a nivel del canal carpiano.
- Lesión traumática previa a nivel de muñeca que limite la extensión.
- Cirugía previa o Dupuytren.
- Tenosinovitis recurrente u otras inflamaciones palmares.
- Artritis reumatoide.
- Tratamiento con NACO.
- Hemodiálisis.

- Embarazo.
- Anomalías anatómicas conocidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Barcenilla A, et al. Carpal tunnel syndrome and its relationship to occupation: a meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2012;51:250-61. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21586523/>
- Atención Primaria en la Red. Fisterra.com. Síndrome del túnel carpiano (fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020). Disponible en: [http://www.fisterra.com/guias-clínicas /Atención Primaria en la Red. Fisterra.com. Síndrome del túnel carpiano \(fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020\). Disponible en: http://www.fisterra.com/guias-clínicas /](http://www.fisterra.com/guias-clínicas /Atención Primaria en la Red. Fisterra.com. Síndrome del túnel carpiano (fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020). Disponible en: http://www.fisterra.com/guias-clínicas /)